

Ansiedad Social

TCC — Ficha clínica

DESCRIPCIÓN DEL TRASTORNO

El Trastorno de Ansiedad Social se caracteriza por miedo intenso y persistente a situaciones sociales en las que el individuo puede ser observado o evaluado negativamente. El modelo de Clark & Wells (1995) describe dos mecanismos clave: el **procesamiento autorreferencial aumentado** (atención centrada en uno mismo) y las **conductas de seguridad** que paradójicamente mantienen y refuerzan el miedo.

TÉCNICAS E INTERVENCIONES TCC — PASO A PASO

1	Psicoeducación del modelo Explicar el ciclo: situación social → anticipación negativa → atención autofocalizada → conductas de seguridad → 'confirmación' del miedo. Identificar las conductas de seguridad específicas del paciente.
2	Redirección atencional Ejercicios para pasar del foco interno ('¿cómo me estoy viendo?') al foco externo ('¿qué está pasando en la conversación?'). Practicar en sesión con role-play. Usar tareas de atención en situaciones reales.
3	Reestructuración de creencias sociales Identificar estándares de actuación perfeccionistas. Trabajo con el 'observador compasivo'. Análisis de evidencia sobre cómo lo perciben los demás realmente vs. cómo cree que lo perciben.
4	Eliminación de conductas de seguridad Listar conductas de seguridad (hablar poco, evitar contacto visual, preparar demasiado). En role-play, practicar primero con y luego sin conducta de seguridad. Evaluar diferencia en ansiedad y en percepción del otro.
5	Experimentos conductuales Diseñar situaciones para testear predicciones. Ej: 'si hablo en clase, todos se van a reír'. Registro sistemático de predicción → resultado → conclusión.
6	Exposición social graduada Jerarquía personalizada de situaciones evitadas. Exposición sin conductas de seguridad. Incluir situaciones de rechazo deliberado para desensibilizar el miedo al juicio negativo.

ADAPTACIONES POR POBLACIÓN

Población	Adaptaciones y consideraciones
Adultos	Foco en contextos laborales, de pareja y de actuación. Evaluar si hay déficit de habilidades sociales o solo inhibición por ansiedad — el tratamiento difiere.

Ansiedad Social

TCC — Ficha clínica

Población	Adaptaciones y consideraciones
Adolescentes	Alta prevalencia. Contexto escolar y de pares es central. El role-play debe ser muy graduado y seguro. Riesgo de soledad social y de impacto en identidad en desarrollo.
Niños	Se presenta como mutismo selectivo o inhibición en nuevos contextos. Involucrar activamente a los padres. Evitar el refuerzo de la evitación desde casa y la escuela.

Clave clínica: Distinguir déficit de habilidades (no sabe cómo relacionarse) de inhibición por ansiedad (sabe pero no puede). El primero requiere entrenamiento; el segundo, exposición. Muchos casos combinan ambos.